

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (GAD-7)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación de Severidad de Ansiedad Generalizada y Cribado Clínico

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Trastorno de Ansiedad Generalizada de 7 Ítems (GAD-7).
Nombre Original (Inglés)	<i>Generalized Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7)</i>
Autores Originales	Drs. Robert L. Spitzer, Kurt Kroenke, Janet B. W. Williams y Bernd Löwe (2006).
Adaptación Española	García-Campayo et al. (2010); validado también por Pedrero-Pérez et al. (2012).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Cribado precoz y monitorización evolutiva de trastornos ansiosos.
Tipo de Instrumento	Autoinforme escalar breve de 7 reactivos (0 a 3) + 1 ítem de impacto en el funcionamiento cotidiano.
Población y Rango	Adolescentes y adultos (>= 12 años). Atención primaria, especializada y cribado poblacional.
Tiempo de Administración	1 a 2 minutos en autoadministración; muy ágil para triaje clínico.
Régimen de Licencia	Dominio público científico. Libre utilización en clínica e investigación sin pago de derechos.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA ANSIEDAD

La GAD-7 fue desarrollada para responder a la necesidad de contar con una herramienta diagnóstica rápida y fiable en atención primaria, donde los trastornos de ansiedad son frecuentemente infradiagnosticados o enmascarados tras quejas somáticas. Sus reactivos se basan estrictamente en los criterios diagnósticos del Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) del DSM-IV y DSM-5.

Fisiopatológicamente, el constructo de ansiedad generalizada se asocia con una hiperreactividad del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA) y una conectividad disfuncional entre el córtex prefrontal ventromedial y el complejo nuclear de la amígdala. Esto se traduce en una falla de los mecanismos inhibitorios de extinción del miedo, manifestada en preocupación incontrolable y tensión motora persistente. Aunque diseñada primordialmente para TAG, la GAD-7 muestra excelente sensibilidad transdiagnóstica como cribado general para Trastorno de Pánico, Fobia Social y Trastorno por Estrés Postraumático.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dominio Clínico	Ítems	Rango Dir.	Contenido Fenomenológico y Criterio DSM
1. Núcleo Cognitivo de Preocupación	1, 2 y 3	0 a 9	Nerviosismo/tensión interna (ítem 1), incapacidad para controlar o parar la preocupación (ítem 2) y preocupación excesiva por diversos temas (ítem 3).
2. Esfera Psicomotora y Tensión	4 y 5	0 a 6	Dificultad acusada para relajarse (ítem 4) e inquietud motora con incapacidad para permanecer sentado o quieto (ítem 5).
3. Reactividad Afectiva y Temor	6 y 7	0 a 6	Irritabilidad y enfado fácil ante contratiempos menores (ítem 6) y miedo o aprensión de que algo terrible pueda suceder (ítem 7).
Impacto Funcional	Ítem Final	Cualitativo	Interferencia de los síntomas ansiosos en el trabajo, cuidado de la casa o relaciones interpersonales (Nada, Algo, Mucho, Extremadamente).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excepcional fiabilidad: coeficiente alfa de Cronbach de 0.936 en atención primaria en España (García-Campayo et al., 2010) y 0.92 en el estudio seminal original.
Sensibilidad y Especificidad	Para el punto de corte óptimo ≥ 10 : sensibilidad del 86.8% y especificidad del 93.4% frente a entrevista clínica semiestructurada (SCID).
Rendimiento Transdiagnóstico	Como cribado general: Trastorno de Pánico (sensibilidad 74%, especificidad 81%), Fobia Social (sensibilidad 72%, especificidad 80%) y TEPT (sensibilidad 66%).
Validez Convergente	Correlación elevada con el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI-Estado $r = 0.75$), BAI ($r = 0.72$) y subescala de ansiedad del HADS ($r = 0.74$).
Versión Ultracorta (GAD-2)	Los 2 primeros ítems (rango 0–6) funcionan como cribado ultrarrápido; un punto de corte ≥ 3 presenta sensibilidad del 86% y especificidad del 83%.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Se evalúa la presencia de cada síntoma durante las **últimas dos semanas**:

- **0** = Para nada | **1** = Varios días | **2** = Más de la mitad de los días | **3** = Casi todos los días.
- **Puntuación Total GAD-7**: Suma directa simple de los 7 reactivos (Rango: **0 a 21 puntos**).
- **Interpretación del ítem de Discapacidad**: No suma a la puntuación cuantitativa; se utiliza clínicamente para validar el Criterio C del DSM (deterioro clínicamente significativo en áreas vitales).

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE

Severidad	Rango	Estado Clínico	Conducta Asistencial Recomendada
Mínima	0 a 4	Ansiedad normal o adaptativa	No requiere intervención profesional. Refuerzo de estilos de vida saludables y técnicas básicas de manejo del estrés.
Leve	5 a 9	Síntomas ansiosos leves / reactivos	Observación clínica y reevaluación si persisten los estresores. Psicoeducación en ansiedad, higiene del sueño y técnicas de relajación.
Moderada	10 a 14	Ansiedad clínicamente significativa (corte ≥ 10)	Indicación formal de tratamiento psicológico (Terapia Cognitivo-Conductual) o farmacológico (ISRS/IRSN). Alta probabilidad de TAG.
Severa	15 a 21	Ansiedad gravemente incapacitante	Intervención especializada prioritaria. Tratamiento farmacológico combinado con psicoterapia intensiva y estrecho seguimiento.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL PUNTO DE CORTE ≥ 10 : En España y guías NICE, una puntuación ≥ 10 representa el umbral óptimo de derivación o inicio terapéutico. Puntuaciones de 8 o 9 en pacientes con comorbilidad orgánica o dolor crónico ameritan confirmación diagnóstica mediante entrevista semiestructurada.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO CLÍNICO Y DETECCIÓN DE COMORBILIDAD

PASOS DE DECISIÓN CLÍNICA ANTE GAD-7 ≥ 10 :

1. **Descarte Orgánico y Tóxico:** Evaluar consumo de cafeína, estimulantes, abstinencia a alcohol o benzodiazepinas y patología tiroidea.
2. **Evaluación de Comorbilidad Depresiva:** Aplicar sistemáticamente PHQ-9 (la comorbilidad TAG-Depresión supera el 60%).
3. **Monitorización de Respuesta:** Medir a las semanas 4, 8 y 12. Un cambio de ≥ 4 puntos representa la Diferencia Mínima Clínicamente Importante (MCID).
4. **Criterio de Remisión:** Puntuación final GAD-7 ≤ 4 puntos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN AMBULATORIA

Paciente: Varón de 39 años, ingeniero de proyectos, que acude a consulta médica por sensación de opresión precordial recurrente, cefaleas occipitales e insomnio de inicio de 5 meses de evolución. ECG y analítica libres de patología orgánica. **Puntuación GAD-7 Total: 14 puntos (Nivel Moderado - Alto riesgo de TAG).** • **Desglose de reactivos:** Ítem 1 = 3 (nerviosismo casi diario); Ítem 2 = 3 (imposible frenar la preocupación); Ítem 3 = 2 (angustia por plazos laborales y economía); Ítem 4 = 2 (tensión muscular constante); Ítem 5 = 1; Ítem 6 = 2 (irritabilidad con su pareja); Ítem 7 = 1 (miedo a fallar). Ítem de discapacidad: «Muy difícil». PHQ-9 concurrente = 6 (depresión leve secundaria). **Conducta Asistencial:** Se diagnostica Trastorno de Ansiedad Generalizada. Se prescribe programa de TCC individual (8 sesiones: reestructuración cognitiva de preocupaciones hipotéticas y entrenamiento en respiración diafragmática) junto a reducción progresiva de estimulantes. A las 8 semanas, la puntuación GAD-7 desciende a 5 puntos (mejoría del 64%), extinguiéndose la opresión precordial y mejorando el patrón de descanso.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTA: CRISIS DE ANGUSTIA AGUDAS En pacientes con puntuaciones muy elevadas en ítems 1 y 7, indagar presencia de ataques de pánico espontáneos con síntomas autonómicos paroxísticos (taquicardia, sensación de asfixia o despersonalización).

RIESGO DE POLIFARMACIA CON BZD Evitar el uso crónico de benzodiazepinas como monoterapia; guías clínicas recomiendan psicoterapia o ISRS/ IRSN de primera línea para prevenir dependencia o tolerancia farmacológica.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. *Archives of Internal Medicine*, 166(10), 1092–1097.
2. García-Campayo, J., Zamorano, E., Ruiz, M. A., Pardo, A., Pérez-Páramo, M., López-Gómez, V., ... & Rejas, J. (2010). Cultural adaptation and validation of the Spanish version of the GAD-7 scale. *Health and Quality of Life Outcomes*, 8(1), 1–11.
3. Löwe, B., Decker, O., Müller, S., Brähler, E., Schellberg, D., Herzog, W., & Herzberg, P. Y. (2008). Validation and standardization of the Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7) in the general population. *Medical Care*, 46(3), 266–274.
4. Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B., Monahan, P. O., & Löwe, B. (2007). Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity, and detection. *Annals of Internal Medicine*, 146(5), 317–325.